

国健医疗

四诊合参体质辨识报告

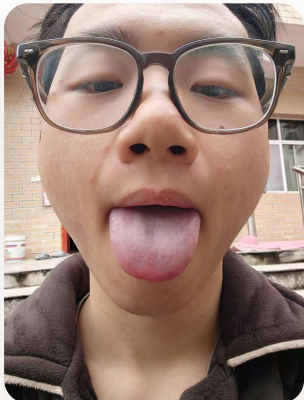
开封市龙亭区 1234452345

患者信息：

姓名：	tang kdfs	性别：	男	年龄：	18岁	生日：	2008-04-10
住址：	sdjfdsgghslkg						

四诊初步诊断

望诊（舌象分析）



舌苔图

核心证候为脾虚湿盛兼轻度阳虚。舌质淡红偏淡，舌体胖大、边有轻度齿痕，苔薄白润，舌面湿润无燥裂，提示脾失健运、水湿内停；舌尖略红为虚火浮越之象。建议：① 饮食宜温补健脾，如山药、莲子、薏苡仁煮粥；② 忌生冷寒凉（如冰饮、西瓜）、油腻甜食，以防助湿伤脾。

补充分析

- 舌象结果已提示当前舌体与舌苔特征，建议与饮食、睡眠、情绪状态一起观察。
- 这类表现通常和运化偏弱、湿邪偏重有关，日常可留意清淡饮食与作息规律。
- 目前变化偏轻，重在早期干预和持续观察，避免继续累积疲劳与饮食失衡。
- 如果后续还有闻诊、问诊或切诊结果，可进一步提高整体辨证的稳定性。

闻诊（体质诊断）

诊断结论：气滞血瘀
置信度：71.5%

体质标签：

气机不畅

音调波动

声音不连贯

补充分析

- 当前闻诊置信度为 71.5%，可作为参考，但不建议单独定性。
- 体质标签显示：气机不畅、音调波动、声音不连贯，说明声音特征与当前体质倾向存在一定关联。
- 若日常出现乏力、气短、咳嗽或情绪波动，建议结合具体症状继续观察。

问诊（症状问卷）

暂未进行症状问卷调查，请补充问诊数据。

切诊（脉搏检测）

心率：43.1 bpm
血氧：97.8 %

信号有效率：80.5 %
采样数：118

中医建议：

【结论性质】本结果基于PPG自动分析，仅反映当前时段脉搏特征倾向，不等同于临床确诊。【融合判定】迟脉倾向（多特征融合）【区分度】主次得分差=1.8（越高表示判定越稳定）【融合得分】数=0.6，迟=2.4，缓=0.4【脉象倾向】迟脉倾向（心率偏慢）【解释】常见于静息、体能训练人群或个体差异，需结合基础心率判读。【脉搏特征】迟脉倾向、节律轻度不齐、脉势偏弱、脉形偏缓、证据:心率偏慢(43.1bpm)、证据:HRV偏高(RMSSD=137.358ms, SDNN=68.679ms)、证据:灌注偏弱(PI=0.2304)【量化摘要】RMSSD=137.358ms，节律CV=0.097，灌注指数PI=0.2304%。

补充分析

- 当前心率 43.1 bpm、血氧 97.8%，可作为循环与呼吸状态的基础参考。
- 信号有效率 80.5%、采样数 118，说明本次测量质量具备一定参考价值。
- 脉搏分析已给出中医建议，可与舌象和问卷结果一起综合判断。

AI 详细分析

不侧重模式下，只输出补充性的 AI 结论、风险提示和后续建议。

好的，作为一名资深中医四诊合参医生，我将基于您提供的全部数据，进行综合分析并诊断。

结论摘要

- 1. 核心证候倾向为脾虚湿盛，兼有气机不畅与虚寒倾向。
 - 证据：舌象（舌淡胖、苔白润）指向脾虚湿盛；脉象（迟、弱）与舌象共同支持虚寒；闻诊（气滞血瘀标签）提示气机运行不畅。
- 2. 体质偏颇，以气虚质、阳虚质、气郁质为主要倾向。
 - 证据：舌体胖大、脉势偏弱提示气虚；舌色偏淡、脉迟提示阳虚；闻诊结论“气滞血瘀”及声音特征指向气机郁滞。
- 3. 当前生理状态显示心率显著偏慢，需结合个人基础情况审慎评估。
 - 证据：切诊测得心率43.1 bpm，算法判定为“迟脉倾向”。需明确是否为运动员体质、静息状态或测量误差。
- 4. 数据完整性存在缺口，问诊（体质问卷）信息缺失，影响辨证的全面性。
 - 证据：wen_questionnaire板块数据缺失，无法获取患者主观症状、生活习惯等关键信息，辨证结论的个性化程度受限。

四诊常规综合

- 望诊（舌象）：
 - 核心发现：算法结论为“脾虚湿盛兼轻度阳虚”。舌色偏淡指数高（65/100），舌体胖大，苔薄白润，符合脾阳不足、水湿不化的典型舌象。
 - 简要建议：饮食当以温阳健脾、利湿化浊为原则，避免生冷、甜腻、油腻食物加重脾湿。
- 闻诊（音频）：
 - 核心发现：算法结论为“气滞血瘀”，置信度中等（0.715）。标签提示“气机不畅”、“声音不连贯”，可能与情绪不畅或气血运行受阻有关。
 - 简要建议：需结合问诊了解情绪、压力状况。调理上可注重疏肝理气，保持情绪舒畅，适当进行深呼吸、散步等舒缓活动。
- 切诊（脉象）：
 - 核心发现：心率43.1 bpm，显著偏慢，算法判定为“迟脉倾向”，并提示“脉势偏弱”。血氧正常。采集质量中等。
 - 简要建议：“迟脉”可见于阳虚寒凝、气血不足，也常见于长期锻炼者。必须明确此心率是否为患者的常态（基础心率），建议在静息状态下复测确认，或咨询西医心内科评估心率过缓的原因。

综合判断

综合四诊信息，中医辨证推断如下：

- 病位：主要在脾，涉及肝、心。
- 病性：本虚标实。本虚以脾阳虚、气虚为主；标实为湿浊内停、气机郁滞。
- 证候倾向：脾阳虚衰，湿浊内蕴，兼有气滞。
- 主要依据：
 - 1. 脾虚湿盛：舌淡胖、苔白润（望诊）是核心证据；脉势偏弱（切诊）支持气虚。
 - 2. 阳虚有寒：舌色偏淡（望诊）、脉迟（切诊）共同指向阳气不足，温煦推动力减弱。
 - 3. 气机不畅：闻诊算法结论及标签指向气滞，虽与“脾虚湿阻”导致的气机不畅机理可互通，但需更多信息确认是否兼有肝郁。

调理建议（可执行）

- 饮食调理：
 - 1. 温补健脾：主食可多吃小米、山药、南瓜、莲子。菜肴可适量加入生姜、陈皮、白扁豆。
 - 2. 忌口关键：严格避免冰淇淋、冷饮、生鱼片等生冷食物，以及奶油、油炸食品等肥甘厚腻之物，以免重伤脾阳、助长湿气。

- **作息起居：**
 1. **防寒保暖：**特别注意腹部、背部及下肢的保暖，避免淋雨、涉水，夏季空调温度不宜过低。
 2. **规律作息：**保证充足睡眠，避免熬夜，因熬夜耗伤阳气。
- **运动养生：**
 1. **温和有氧：**推荐散步、慢跑、太极拳、八段锦等，以微微出汗、不感疲劳为度，有助于阳气升发、气血流通。
 2. **避免过汗：**剧烈运动导致大汗淋漓会“气随津泄”，反而加重气虚。运动后及时擦干，更换干爽衣物。

数据缺口提示

- **缺失板块：问诊（体质问卷）。**
- **补充检查建议：**
 1. **补充主观信息：**强烈建议完成标准化的中医体质辨识问卷。这能提供关于疲劳感、怕冷程度、食欲、大便情况、情绪状态等关键症状信息，是验证当前辨证（如阳虚、气郁）和发现潜在问题（如湿热、阴虚）不可或缺的一环。
 2. **明确心率情况：**针对切诊发现的“心率偏慢（43.1 bpm）”，建议在清晨静息状态下复测脉搏，或使用可穿戴设备连续监测数日，以获取可靠的基础心率数据。若持续偏低且伴有头晕、乏力等症状，应咨询心血管专科。

免责声明：本分析基于有限的多模态数据生成，不能替代执业医师的面对面诊断。所有调理建议均需在个人实际感受下调整，如有不适或疑问，请及时就医。

报告生成时间：2026/4/10 11:41:50

本系统仅为中医诊断辅助工具，不具备医疗资质，输出结果仅供参考，不能替代专业中医师面诊及诊疗方案

签发医师：张翰

3个月